

Participants

Date 2026-03-31

Ordine del giorno

- Aggiornamento linee guida e materiali formativi AREU
- Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione nel paziente adulto
- Morte cardiaca improvvisa e arresto cardiocircolatorio
- Ritmi di presentazione e percentuali di sopravvivenza
- Catena della sopravvivenza e sue evoluzioni
- Sequenza BLSD a due soccorritori
- Compressioni toraciche esterne e tecniche di ventilazione
- Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE)
- Protocollo delle tre analisi e comunicazione con SOREU
- Particolarità: vittima di trauma in arresto
- Canula orofaringea e ventilazione difficile
- Arresto durante il trasporto
- Posizioni alternative delle piastre e dispositivi automatici

Argomenti discussi

Aggiornamento linee guida e materiali formativi AREU

L'istruttore ha informato che le linee guida utilizzate sono datate e che AREU non ha ancora aggiornato il materiale formativo alle Linee Guida 2025. È previsto l'aggiornamento del corso 120 ore entro l'anno corrente. Nel frattempo, il materiale attuale rimane valido per la formazione.

Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione nel paziente adulto

L'obiettivo della sessione è insegnare come trattare situazioni pericolose per la vita che risultano in arresto cardiocircolatorio. Si è discusso che l'arresto cardiocircolatorio è una patologia tempo-dipendente dove ogni minuto è cruciale per la sopravvivenza del paziente.

Morte cardiaca improvvisa e arresto cardiocircolatorio

La prima causa di arresto cardiocircolatorio nel paziente adulto è una patologia cardiaca, prevalentemente l'infarto miocardico acuto. L'evento può essere preceduto o meno da prodromi come dolore toracico, sudorazione algida e dispnea. La perdita di coscienza è il primo segno, seguita da arresto respiratorio e cardiaco.

Ritmi di presentazione e percentuali di sopravvivenza

Solo il 25% dei casi presenta ritmi defibrillabili (tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare). Gli altri ritmi come asistolia e PEA non beneficiano della terapia elettrica. Ogni minuto senza manovre di rianimazione comporta una perdita del 10% di possibilità di sopravvivenza cerebrale. Le compressioni toraciche precoci possono quasi raddoppiare il tempo disponibile.

Catena della sopravvivenza e sue evoluzioni

La catena della sopravvivenza comprende: riconoscimento e attivazione del sistema di emergenza, RCP immediata di alta qualità, defibrillazione rapida, sistema di emergenza avanzato e ospedalizzazione appropriata. Nelle nuove linee guida, il primo anello è stato ampliato per enfatizzare la chiamata al 112, mentre RCP e defibrillazione sono stati fusi data la diffusione dei defibrillatori. È stato aggiunto l'anello del "patient centered care" per garantire un recupero ottimale senza esiti neurologici invalidanti.

Sequenza BLSD a due soccorritori

La sequenza prevede: colpo d'occhio e sicurezza della scena, valutazione di coscienza e respiro, posizionamento su piano rigido se incosciente. In caso di respiro assente o gasping, si comunicano immediatamente l'arresto, si posiziona il paziente, si scopre il torace e si iniziano le compressioni toraciche mentre un secondo soccorritore prepara il defibrillatore e chiama la centrale.

Compressioni toraciche esterne e tecniche di ventilazione

Le compressioni devono essere eseguite al centro del torace, sulla metà inferiore dello sterno, con profondità di almeno 5 cm e non più di 6 cm. La frequenza deve essere tra 100 e 120 compressioni al minuto, mantenendo uguale il tempo di compressione e rilasciamento. Le interruzioni non devono superare i 10 secondi. Le ventilazioni devono insufflare 500-600 ml, verificando l'espansione toracica.

Utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE)

Il defibrillatore deve essere applicato appena disponibile. La preparazione del torace richiede rasatura e asciugatura nelle aree di applicazione delle piastre. La posizione antero laterale è il gold standard perché minimizza il tessuto tra piastre e muscolo cardiaco. Durante l'analisi e la scarica è fondamentale garantire la sicurezza con la "filastrocca" per evitare contatti con il paziente.

Protocollo delle tre analisi e comunicazione con SOREU

Quando il mezzo avanzato (MSA) non è in arrivo, si completano tre analisi e si comunica con SOREU per ricevere istruzioni. Se già alla prima chiamata viene comunicata la destinazione

ospedaliera, non è necessario richiamare al termine della terza analisi. Non esiste "analisi zero": la prima analisi conta come prima analisi.

Particolarità: vittima di trauma in arresto

Nel paziente traumatizzato in arresto, l'apertura delle vie aeree deve essere effettuata con sublussazione della mandibola, non con estensione del capo. Se impossibile, è consentita una modica estensione del capo. Il rachide cervicale deve essere mantenuto immobilizzato manualmente; è sconsigliato il posizionamento del collare cervicale durante l'arresto.

Canula orofaringea e ventilazione difficile

La cannula orofaringea è opzionale ma fortemente consigliata, diventando obbligatoria in caso di ventilazione difficile. Nel trauma è particolarmente consigliata per garantire la pervietà delle vie aeree senza estensione del capo. Si misura dalla rima labiale al lobo dell'orecchio e si inserisce al contrario nel paziente adulto.

Arresto durante il trasporto

Se il paziente va in arresto durante il trasporto, si deve fermare il mezzo immediatamente e iniziare la sequenza BLS, contattando SOREU anche se in vista dell'ospedale. Il protocollo attuale richiede di fermarsi sempre, non di proseguire fino all'ospedale.

Posizioni alternative delle piastre e dispositivi automatici

Le posizioni alternative (latero-laterale o antero-posteriore) si utilizzano quando è presente un device impiantato (port, pacemaker) nell'area clavare. I massaggiatori automatici come Lucas sono utili in situazioni logisticamente difficili, anche se le ultime linee guida non ne raccomandano l'uso routinario preferendo il massaggio manuale.

Azioni

- **AREU:** Aggiornare il materiale formativo del corso 120 ore alle Linee Guida 2025 - *Scadenza: entro l'anno corrente*
- **Soccorritori:** Sensibilizzare la popolazione sulla chiamata al numero unico di emergenza 112 - *Scadenza: continuativa*
- **Equipaggi:** Portare sempre il defibrillatore in casa del paziente, indipendentemente dal codice di intervento - *Scadenza: immediata*
- **Soccorritori:** Garantire compressioni toraciche continue con interruzioni non superiori a 10 secondi - *Scadenza: ogni intervento*
- **Equipaggi:** Contattare SOREU al termine della terza analisi quando MSA non è in arrivo e non sono state fornite istruzioni - *Scadenza: ogni arresto cardiocircolatorio*
- **Equipaggi:** In caso di arresto durante il trasporto, fermare sempre il mezzo e contattare SOREU anche se in vista dell'ospedale - *Scadenza: ogni situazione di arresto in itinere*

Approfondimenti

Problema: Materiale formativo non aggiornato alle Linee Guida 2025

Soluzione: Continuare a utilizzare il materiale attuale fino all'aggiornamento ufficiale da parte di AREU, previsto entro l'anno. Le linee guida attuali rimangono valide per la formazione.

Problema: Confusione sull'esistenza dell'"analisi zero"

Soluzione: Chiarimento definitivo che non esiste analisi zero: la prima analisi effettuata conta come prima analisi, la seconda come seconda, la terza come terza. Questo evita di uscire dal protocollo locale.

Problema: Dubbi sulla gestione del paziente con respiro anomalo (gasping)

Soluzione: Il paziente in gasping è considerato in arresto cardiocircolatorio e deve essere massaggiato. Le linee guida 2015 raccomandano di iniziare le compressioni anche nei pazienti con respiro anormale per evitare di non trattare pazienti in arresto.

Problema: Incertezza sulla rimozione del collare cervicale durante arresto traumatico

Soluzione: Il collare cervicale è sconsigliato durante l'arresto. Se già posizionato, può essere lasciato se non interferisce con le manovre; va rimosso solo se ostacola le procedure di rianimazione. Con equipaggio ridotto, utilizzare le ginocchia per mantenere l'immobilizzazione.

Problema: Dubbi sull'utilizzo della canula orofaringea in caso di sospetto corpo estraneo

Soluzione: La canula è obbligatoria in caso di ventilazione difficile, inclusi i casi di sospetto corpo estraneo. Se la ventilazione è difficile, posizionare la canula; se non lo è, rimane opzionale ma fortemente consigliata.

Problema: Gestione dell'ossigeno durante la defibrillazione

Soluzione: Il tubo dell'ossigeno può rimanere collegato al paziente. È sufficiente allontanare l'ambu girando il flusso di ossigeno nella direzione opposta alle piastre, senza necessità di scollegare il tubo.

Problema: Preoccupazione per le conseguenze del massaggio su paziente non in arresto

Soluzione: Le evidenze scientifiche dimostrano che massaggiare un paziente non in arresto non causa danni gravi (al massimo fratture costali), mentre non massaggiare un paziente in arresto è letale. In caso di dubbio, è meglio iniziare le compressioni e contattare la centrale.